

MAPA DE EMPATIA

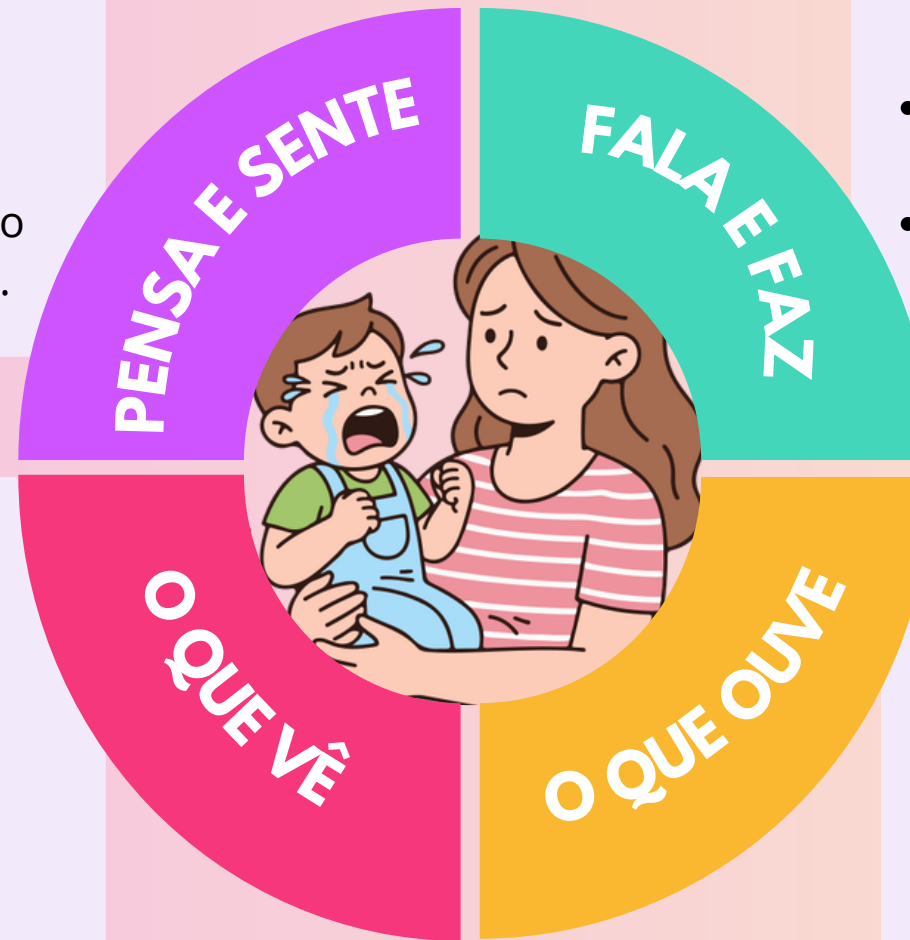
- Sandra: Frustração por ser "secretária" em vez de enfermeira.
- Joana: Medo de perder um diagnóstico grave por pressa.
- Mãe do Kauê: Angústia por não saber cuidar de um bebê tão frágil.
- Unificado: Sobrecarga emocional e o desejo profundo de que a tecnologia fosse uma ponte, não um muro.

- Sandra: Fichas de papel e o "vácuo" após a alta.
- Joana: Filas de 40 pessoas e dados incompletos no sistema.
- Família do Kauê: Barreiras geográficas e falta de rede de apoio em Jaboaão.
- Unificado: Um sistema de saúde fragmentado onde a informação não atravessa a fronteira do hospital para a comunidade.

DORES



- Técnicas: Sistemas fechados (PEC vs. Hospital), retrabalho de digitação.
- Humanas: A "invisibilidade" do bebê após a alta.
- Operacionais: Atraso na identificação de riscos biopsicossociais.



- Sandra: "Preciso garantir que esse bebê não morra em casa."
- Joana: "Não tenho tempo para abrir cada prontuário e achar os riscos."
- ACS (para Kauê): "Preciso achar essa família para a visita de 48h."
- Unificado: Discursos focados em sobrevivência e urgência, mas travados pela burocracia.

- Sandra: Alertas de UTI e reclamações de que o distrito não atende.
- Joana: "Doutora, o sistema caiu" e relatos vagos de mães sobre a internação.
- Família do Kauê: Conselhos de vizinhos e o silêncio do sistema (a falta de chamadas).
- Unificado: Ruídos de comunicação e a sensação de que ninguém sabe exatamente o que o outro setor está fazendo.

GANHOS



- Agilizar o prontuário
- Facilitar o monitoramento fora da UBS.
- Facilitar na intervenção por área.
- Facilita o planejamento de longo prazo.
- Monitoramento geral de casos de risco de vida.

